



**ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»**

вул. Ярославська, 41, м. Київ, 04071, тел. (044) 334-56-89
E-mail: info@phc.org.ua, код ЄДРПОУ 40524109

№ _____

На _____ від _____

**Керівникам структурних
підрозділів з питань охорони
здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) та
обласних державних адміністрацій**

Щодо алгоритму тестування на ВІЛ
із застосуванням швидких тестів для
виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та
антигену р24 ВІЛ-1 перед призначенням
та під час впровадження ДКП ВІЛ-інфекції
у закладах охорони здоров'я

Державна установа «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (далі – Центр) висловлює свою повагу та інформує про наступне.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 р. №1415-р «Про схвалення Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року», розпорядження Кабінету міністрів України від 18.06.2024 р. №564-р «Про затвердження операційного плану заходів з реалізації у 2024-2026 роках Державної стратегії у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам на період до 2030 року», наказів Міністерства охорони здоров'я України: від 05.04.2019 р. №794 «Про удосконалення системи управління якістю лабораторних досліджень у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу», від 16.11.2022 р. №2092 «Про затвердження стандартів медичної допомоги «ВІЛ-інфекція» у редакції наказу МОЗ України від 15.08.2023 р. №1465 «Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги «ВІЛ-інфекція» з метою забезпечення населення послугами тестування на ВІЛ-інфекцію під час надання медичних послуг з доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції до регіонів поставлені комбіновані швидкі тести для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену р24 ВІЛ-1 «Determine HIV Early



№ 04-09/26/5821/24 від 30.09.2024
КЕП РОСАДА МИХАЙЛО
ОЛЕКСІЙОВИЧ
5E984D526F82F38F04000000182E4F01F83DE404

ДУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України"
№ 04-09/26/5821/24 від 30.09.2024



№22-4828/01-11/1-24 від 01.10.2024

Detect» виробництва Abbott Diagnostics Medical Co., Ltd, Japan, які необхідно застосовувати для діагностики ВІЛ-інфекції у пацієнтів перед призначенням та під час впровадження ДКП ВІЛ-інфекції у закладах охорони здоров'я. Алгоритм обстеження на ВІЛ-інфекцію комбінованими швидкими тестами для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ ½ та антигену р24 ВІЛ-1 додається.

Додаток: «Алгоритм обстеження на ВІЛ-інфекцію комбінованими швидкими тестами для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ ½ та антигену р24 ВІЛ-1» на 2 арк. в 1 прим.

Генеральний директор

Михайло РОСАДА

Бондарева Ліна, 050-631-43-49
Андріанова Ірина, 097-316-61-78

**Алгоритм обстеження на ВІЛ-інфекцію комбінованими швидкими тестами
для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ 1/2 та антигену p24 ВІЛ-1**

1. Етап скринінгу комбінованим тестом (A1). У разі отримання негативного результату дослідження (A1–): надання довідки (форма №503-10/о) про негативний ВІЛ-статус.

2. У разі отримання позитивного результату комбінованого тесту (A1+) у будь-якій з комбінацій (антиген p24ВІЛ-1+ та антитіла до ВІЛ-1/2–; антиген p24ВІЛ-1+ та антитіла до ВІЛ-1/2+; антиген p24ВІЛ-1– та антитіла до ВІЛ-1/2+) дослідження повторюють комбінованим ШТ того ж найменування (A1) для виключення можливих помилок. Якщо після повторного тестування отримано негативний результат (A1–), зразок вважається таким, що не містить серологічних маркерів ВІЛ і надається довідка про негативний ВІЛ-статус (форма №503-10/о).

3. У разі отримання позитивного повторного результату (A1+) у комбінаціях, коли виявлені антитіла (антиген p24ВІЛ-1+ та антитіла до ВІЛ-1/2+; антиген p24ВІЛ-1– та антитіла до ВІЛ-1/2+), зразок вважається таким, що потребує проведення підтверджувальних досліджень з виявлення серологічних маркерів ВІЛ на верифікаційному етапі дослідження із застосуванням тестів для виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 (A2 та A3).

4. Якщо при повторному тестуванні комбінованим тестом A1 отримано результат (антиген p24ВІЛ-1+ та антитіла до ВІЛ-1/2–), проводиться визначення рівня ВН. Якщо рівень ВН більше визначуваного рівня – ВІЛ-позитивний статус підтверджено, про що надається довідка (форма №503-10/о); необхідно провести ідентифікаційний етап із застосуванням трьох тестів, призначених для виявлення антитіл до ВІЛ 1/2, протягом 1 місяця для підтвердження сероконверсії. Якщо ВН менше визначуваного рівня, необхідно повторити обстеження згідно з алгоритмом тестування через 14 днів.

5. На верифікаційному етапі використовують ШТ на антитіла до ВІЛ (A2 та A3). При отриманні позитивного результату ШТ на антитіла до ВІЛ (A2+) слід провести подальшу верифікацію з використанням ШТ (A3). При отриманні позитивного результату (A3+) ВІЛ-позитивний статус підтверджується, про що надається довідка (форма №503-10/о); наступним кроком є етап ідентифікації. При отриманні негативного результату (A3–) необхідно повторити дослідження згідно з алгоритмом тестування через 14 днів.

6. При отриманні негативного результату ШТ на антитіла до ВІЛ (A2–) у випадках:

якщо на етапі повторного тестування ШТ (А1) отримано результат (антиген р24ВІЛ-1– та антитіла до ВІЛ-1/2+), необхідно повторити дослідження згідно алгоритму тестування через 14 днів;

якщо на етапі повторного тестування ШТ (А1) отримано результат (антиген р24ВІЛ-1+ та антитіла до ВІЛ-1/2+), слід провести визначення рівня ВН. Якщо рівень ВН вище визначуваного рівня – ВІЛ-позитивний статус підтверджено, про що надається довідка (форма №503-10/о); необхідно провести ідентифікаційний етап із застосуванням трьох ШТ, призначених для виявлення антитіл до ВІЛ ½, протягом 1 місяця для підтвердження сероконверсії. Якщо рівень ВН нижче визначуваного рівня, необхідно повторити обстеження згідно з алгоритмом тестування через 14 днів.

Комбіновані тести, що призначені для одночасного виявлення антитіл до ВІЛ-1/2 та антигену р24 ВІЛ-1, використовують для:

- діагностики гострої ВІЛ-інфекції;
- обстеження вагітних жінок;
- обстеження осіб, які потребують ДКП;
- обстеження осіб під час проведення ДКП;
- обстеження осіб, які виявили бажання стати донорами;
- обстеження донорів крові, органів, тканин, клітин;
- встановлення ВІЛ-статусу в осіб з клінічними ознаками прогресуючої ВІЛ-інфекції.

